EXAMEN DE SESSION NORMALE (SN) - SUPÉRIEUR

Session Normale (SN) - ANAT 101 : Anatomie Générale & Ostéologie (Niveau 1 Médecine) - Année 2023-2024

Épreuve : Anatomie & Embryologie | Niveau : Niveau 1 Médecine | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE I : OSTÉOLOGIE & ARTHROLOGIE DU MEMBRE THORACIQUE (6 points)

Étude morphologique de la ceinture scapulaire et du squelette du bras chez le sujet adulte.

1. Morphologie de l'humérus et de la scapula :

a) Décrire l'épiphyse proximale de l'humérus : tête humérale, col anatomique, tubercule majeur (trochiter), tubercule mineur (trochin) et sillon intertuberculaire (gouttière bicipitale).

b) Quels muscles de la coiffe des rotateurs s'insèrent respectivement sur les 3 facettes du tubercule majeur ?

c) Définir le col chirurgical de l'humérus et indiquer la structure vasculo-nerveuse majeure qui lui est intimement liée.

2. Articulation gléno-humérale (scapulo-humérale) :

a) Préciser le type d'articulation (énarthrose ou sphéroïde) et ses degrés de liberté dans l'espace.

b) Décrire le rôle biomécanique du labrum (bourrelet glénoïdien) et des ligaments gléno-huméraux supérieur, moyen et inférieur.

PARTIE II : MYOLOGIE & SYSTÉMATISATION DU PLEXUS BRACHIAL (7 points)

Innervation motrice et sensitive du membre supérieur à partir des rameaux ventraux des racines rachidiennes cervicales et thoraciques.

1. Constitution anatomique du plexus brachial :

a) Énumérer les 5 racines rachidiennes constituant le plexus brachial (C5, C6, C7, C8, T1).

b) Détailler la formation des 3 troncs primaires (supérieur, moyen, inférieur) et des 3 faisceaux (latéral, médial, postérieur) par rapport à l'artère axillaire.

c) Préciser l'origine radiculaire et le faisceau de provenance des 5 grandes branches terminales : nerf musculocutané, nerf médian, nerf ulnaire, nerf radial, nerf axillaire.

2. Topographie des loges musculaires du bras :

a) Décrire les insertions, l'innervation et l'action principale du muscle biceps brachial et du muscle brachial antérieur.

b) Quelle est l'innervation motrice exclusive de la loge postérieure du bras (muscle triceps brachial) ?

PARTIE III : CAS CLINIQUE D'URGENCE & ANATOMIE APPLIQUÉE (7 points)

Cas clinique réel d'accidenté de la circulation reçu au pavillon des urgences de l'Hôpital Central de Yaoundé.

1. Observation clinique :

Monsieur T., 28 ans, livreur à moto à Yaoundé, chute sur son bras droit. La radiographie met en évidence une fracture spiroïde déplacée du tiers moyen de la diaphyse humérale.

À l'examen clinique, le patient présente une impossibilité d'étendre le poignet et les premières phalanges des doigts, réalisant l'attitude de 'main tombante en col de cygne'. Il signale également une anesthésie de la face dorsale de la première commissure interdigitale.

2. Questions d'évaluation anatomo-clinique :

a) Quel est le nerf lésé au niveau du sillon du nerf radial (gouttière de torsion) de l'humérus ?

b) Justifier la sémiologie motrice observée au niveau de l'avant-bras et de la main en rappelant les muscles énervés.

c) Quel vaisseau artériel chemine de concert avec ce nerf dans le sillon spiral et risque d'être comprimé ou lacéré par les fragments osseux ?

d) Si la fracture avait siégé au niveau du col chirurgical, quel autre nerf et quelle anomalie motrice (paralysie du deltoïde) aurions-nous constatés ?